Comment le CHU fait face

BORDEAUX Avec 14 000 salariés à encadrer, l'hôpital est confronté à de multiples risques de collusion

Les centres hospitaliers universitaires (CHU) ont pris leur temps en termes de prévention des conflits d'intérêts. Bordeaux ne fait pas exception à la règle, se préparant à nommer Lionel Collet au poste de déontologue. Huit ans après la promulgation de la loi Bertrand (lire par ailleurs). « Une personnalité extérieure, médecin expérimenté », selon la directrice générale adjointe Stéphanie Fazi-Leblanc. Les saisines de cette personnalité par le personnel devraient toutefois rester soumises au visa de la direction juridique de l'hôpital.

Cette nomination s'inspire de travaux d'un groupe de réflexion en interne sur la gestion des liens d'intérêts, remis l'été dernier et à l'initiative de deux médecins. Faut-il y voir également la conséquence d'un contrôle sur pièce et sur place mené par l'Agence française anticorruption au printemps 2017 ? Le CHU confirme avoir tenu compte de cet audit mais n'a pas souhaité nous en communiquer le contenu.

1 Un contrôle naissant des déclarations d'intérêts

Obligatoires depuis la loi Bertrand de 2011, les déclarations publiques d'intérêts (DPI) font apparaître les liens directs ou par personne interposée que le déclarant a eu durant les cinq années précédant sa prise de fonction. Jusqu'à l'an dernier, seules trois personnes y étaient soumises. Mais depuis le mois de juin 2019, la direction a finalement étendu le dispositif à 168 professionnels participants aux processus d'achats. Un recensement « inachevé », tous les participants n'ayant pas encore transmis leurs déclarations. « Chaque président d'instance au sein du CHU est chargé d'analyser les déclarations d'intérêts au sein de son instance. » Ingénieurs, acheteurs et administratifs y ont été inclus. « On fait davantage de contrôles avec la base Transparence santé », assure également la direction de l'hôpital, qui reconnaît : « Avant, c'était essentiellement déclaratif. »

2 Le casse-tête des cumuls d'activités

Dans la revue interne du CHU de Bordeaux, l'administration rappelle à ses personnels que « l'exercice d'une activité accessoire, qui conduit donc à un cumul d'emplois, est en principe interdit dans la fonction publique ». Interdit… sauf dérogations. C'est évidemment dans ces « dérogations » que se niche l'essentiel des liens entre médecins hospitaliers et industrie : contrats de consultants, d'expertise, participations dans des startups…

En 2018, le CHU nous précise avoir reçu 453 demandes d'activités accessoires pour 206 praticiens parmi les 1 500 de l'hôpital. Mais selon les déclarations des laboratoires, près de 400 médecins rattachés au CHU avaient passé plus de 1 000 conventions rémunérées avec l'industrie, cette même année (sans compter les conventions d'hospitalité). Une nouvelle commission, émanation du directoire, a été instituée en juin 2019 afin d'analyser les demandes au regard des critères prévus par la réglementation (253 demandes sur 282 ont été acceptées depuis cette date).

Le CHU s'apprête à nommer un déontologue… huit ans après la promulgation de la loi Bertrand. PHOTO CLAUDE PETIT/« SUD OUEST »

Depuis juin également, le CHU établit une liste de critères plus directifs : les demandes ne doivent pas excéder dix heures par semaine et vingt jours par an (hors du temps de travail). Une grille encore provisoire qui ne prévoit pas de limite de rémunération pour ces demandes de cumul d'activités. Un sujet toujours éruptif.

3 Des visiteurs médicaux en liberté

Malgré les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS), le CHU de Bordeaux encadre peu l'activité des visiteurs médicaux au sein de l'hôpital et n'a aucune idée du nombre d'interventions de ces porte-parole des laboratoires en son sein au cours de l'année 2018. Un chantier « à venir en 2020 » après « des premières consignes en 2019 ». Des médecins travaillent actuellement pour rédiger « une charte de la visite médicale au CHU de Bordeaux ». Faute de mieux, c'est pour l'heure celle du syndicat des entreprises du médicament qui est appliquée.

4 Des marchés publics et des flux financiers mieux suivis

La lutte contre la corruption et la bonne gestion des procédures de passation des marchés publics sont « en tête des préoccupations du CHU, assure la direction. Peu d'entreprises ont autant de contrôles que nous ». Pour dissiper tout malentendu, le CHU n'a aucun lien financier avec les laboratoires en dehors des essais cliniques et de la recherche. « Ce ne sont pas spécifiquement les médecins qui sont concernés mais l'ensemble des personnels qui participent aux achats. Des contrôles sont positionnés sur toutes les zones de risques », explique le CHU qui avait dû essuyer, il y a quelques années, une retentissante affaire de trafic d'influence entre un ingénieur biomédical et une société de dispositifs médicaux de pointe.

5 L'opacité des associations de professionnels

Domiciliées au CHU, une cinquantaine d'associations de professionnels avaient des liens d'intérêts avec l'industrie de la santé en 2018, selon les déclarations des laboratoires. Le double de ce qu'annonce avoir recensé l'hôpital ! Quelle fut la destination finale de ces financements ? Interrogée, la direction annonce « une actualisation de la liste » et « une systématisation du contrôle des comptes ».

« Sans l'industrie, on n'y arriverait jamais »

La gestion des conflits d'intérêts divise la sphère médicale. Paroles de médecins

« J'espère que vous saurez faire preuve de nuance sur ce sujet. » Michel Haïssaguerre, sommité de la cardiologie, chef de service au CHU de Bordeaux, ne masque pas son inquiétude. La question des conflits d'intérêts agace autant qu'elle fascine. Surtout depuis l'affaire du Mediator, qui a révélé l'imbrication des sphères médicale et industrielle. « Imaginer qu'on devienne corrompu et qu'on prescrive pour des raisons financières et strictement personnelles, ça me paraît fou », glisse le professeur Pierre Jaïs, un autre éminent cardiologue bordelais.

« On préférerait faire sans »

Interroger des médecins sur la question de l'influence de l'industrie pharmaceutique, c'est pourtant l'assurance de recueillir moult anecdotes sur les dérives du système. Mais reléguées à des temps que les praticiens jurent révolus : tel laboratoire qui préconisait de financer un amphithéâtre à condition, qu'à l'intérieur, ses produits y soient vantés ; telle marque de pacemakers exclue d'un marché public mais qui réapparaissait miraculeusement dans le circuit de l'hôpital via une étude clinique ; où, plus fréquemment, ces souvenirs de sourires entendus entre collègues à l'évocation d'une molécule soudainement devenue à la mode.

« La plupart du temps, les médecins reconnaissent la possibilité d'une influence de l'industrie sur le travail de leurs pairs. Mais ils peinent à admettre qu'ils peuvent eux-mêmes en être victimes », glisse le professeur Marco Romero, à l'origine d'une formation reconnue sur le sujet à la faculté de Bordeaux. La disette chronique des hôpitaux publics ouvre un boulevard aux industriels : « On a besoin d'être tenus au courant de l'évolution des connaissances au niveau international, on ne progresse pas sans ça. Le fonds de formation de l'hôpital, qui est réglementé, c'est 0,5 % de la masse salariale médicale. On préférerait faire sans l'industrie mais on n'y arriverait jamais ! » s'exclame le professeur Philippe Morlat, président de la Commission médicale d'établissement au CHU de Bordeaux.

Le professeur Marco Romero.
PHOTO PASCAL BATS/« SUD OUEST »

À l'américaine

Les congrès financés par les labos ? « On y est tout le temps. C'est même la meilleure formation continue qu'on puisse imaginer. Je suis en déplacement pour ces congrès à peu près deux fois par mois. À grosse dose », abonde Pierre Jaïs. Pourquoi ces largesses de l'industrie à l'égard des professionnels de santé ? Philippe Morlat reconnaît ne s'être « jamais posé la question de cette façon ». « Je travaille en ce moment avec une startup américaine qui a développé un changement d'énergie radical dans mon domaine et c'est une chance inouïe dans une carrière », poursuit Pierre Jaïs, qui est devenu actionnaire de la startup à titre personnel.

« C'est la façon de faire américaine. Les actions seront ensuite transférées à l'Institut de recherche », assure-t-il. « Il faut garder les bons chercheurs dans le service public. Sur les salaires, vous ne pourrez jamais vous aligner sur le privé. Mais vous pouvez les garder en leur proposant des projets fascinants. À condition d'avoir des garde-fous », avertit le pharmacologue Bernard Bégaud.

Le professeur Philippe Morlat.
PHOTO QUENTIN SALINIER/ « SUD OUEST »

« Dans la recherche, il est difficile de résister à un financement de l'industrie et celle-ci le sait très bien. Les médecins avec leurs patients sont comme des parents avec leurs enfants : nous voulons le meilleur traitement, le plus innovant, le plus cher… Nous avons toujours l'impression de faire le bien. Mais cela ne nous incite pas à la vigilance dans nos relations avec ces financeurs », pense un professeur du CHU de Bordeaux, qui a requis l'anonymat.

Injonctions contradictoires

Il faut dire que la sphère médicale est traversée d'injonctions paradoxales. « D'un côté, on nous dit que l'industrie c'est le mal et de l'autre, on laisse perdurer un système nous incitant à travailler avec elle », relève Philippe Morlat. « Les établissements touchent d'ailleurs des subventions au prorata de recherches à promotion industrielle réalisées. L'objectif étant que ces recherches soient effectuées en France », remarque le professeur Nicholas Moore.

De fait, l'industrie reste un gros pourvoyeur d'études. Quitte à imposer ses protocoles. « Je vois mal les laboratoires ne pas garder la main sur une étude concernant sa molécule, poursuit Nicholas Moore. Mais y aurait-il un gain sanitaire à ce qu'ils aillent le faire dans le tiers-monde ? » Dans ces conditions, l'hôpital public a-t-il encore la main sur sa politique ? « C'est l'industrie qui a besoin de nous, pas l'inverse », jurent en chœur la plupart des médecins interrogés. Sur cette question, la culture du doute n'a pas irrigué le monde hospitalo-universitaire.